EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 68511
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-03 09:53:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN MARTINEZ SALDANA			RUN	: 11.177.407-2
F.Nac	: 04-10-1962	Edad	: 60 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: Diego Portales 952			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-07-31	Fecha Egreso	: 2023-08-03 09:53:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico brazo posterior cápsula interna derecha, obs territorio ACoA, etiología lacunar

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Diestro mRS 0 Paciente previamente asintomático, con consulta en enero del 2023 por cuadro de disartria aislada transitoria que se interpretó en ese entonces secundario a hipertensión arterial. Desde 3 semanas con hipoestesia y debilidad crural izquierda que habría sido estudiado sin diagnóstico. Consulta por cuadro del despertar del 31/07/23 a las 05:00 horas, consistente en disartria, debilidad FBC izquierda asociado a hipoestesia BC izquierda. Ingresa a las 08:35 horas a SU de HSC. Al ingreso con FC 88 lpm RR, ECG en ritmo sinusal, PA 190/90 mmHg, T° 36.6°c, Sat 95%, HGT 273. Al examen se describe disartria y paresia de HC izquierdo. Se complementó estudio con laboratorio general, sin alteraciones de relevancia y angioTC de cerebro y cuello en que no se hacen evidente lesiones. En fase angiográfica sin estenosis significativas intra ni extracraneanas. Se toma conocimiento del caso el 31/07/23, deficit del despertar y fuera de periodo de reperfusión sin LVO. Paciente en buenas condiciones generales, afebril, hemodinamia estable, con regresión parcial de síntomas de ingreso

Evolución
Paciente BEG, HDN estable con HTA leve, afebril, eupneico, hiperglicemia vespertina en control parcial, tolera bien alimentación VO y KNTM, sin fluctuaciones, RS al monitor, refiere cefalea frontal leve, sin otras molestias, déficit en regresión progresiva.
Ayer se tomó ETT y se instaló Holter de ritmo.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy posterior a retiro de monitor Holter de ritmo, completar DAPT por ACV menor por 21 días y control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 días aprox.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-Completar DAPT por ACV menor por 21 días
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 días aprox
-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/d
2. -Clopidogrel 75 mg/d por 17 días, luego suspender
3. -Atorvastatina (40 mg) 2 comp/noche
4. -Famotidina 40 mg/d
5. -Losartan 50 mg c/12h
6. -Metformina 850 mg c/12h
7. -Insulina NPH 16U AM - 6U PM

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 20/08/23 TC de encéfalo sin contraste: Consolidación hipodensidad talámica lateral y capsular posterior derecha
- 31/07/23 ColT 246, HDL 36, LDL 133, TGL 387, PCR 6.5. TTPa 27. TSH 0.78. T4L 0.88. VitB12 257. HbA1c 10.7. RPR no reactivo.
- 31/07/23 TC de encéfalo sin contraste: se hace evidente hipodensidad talamica-capsular posterior derecha.
- 31/07/23 AngioTC de cerebro y cuello: no se hacen evidente lesiones. En fase angiográfica sin estenosis significativas intra ni extracraneanas.
- 31/07/23 Glic 288, Creat 0.6, MDRD 139, Uremia 48, ELP 138/4.1/105, Hb 14, Hto 40.1, Leuco 5200, Plaq 202.000, VHS 21.P Hepático normal. INR 0.91. Tropo 4.9.

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico:
-Mental: vigil, OTE, atención N, lenguaje N, gnosias N, praxias N
-PC: CV por amenaza impresiona N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC izquierda leve, disartria(-), hipoestesia táctil facial izq, nistagmo(-), pares bajos N
-Motor: BC der M5, ESI M4(+), EII M4, RCP flexor derecho e indiferente izq
-Cerebelo: dismetría y disdiadococinesia proporcional a paresia en hemicuerpo izq, resto conservado
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO